מאת: נעמה גרינולד ,פסיכולוגית קלינית, מטפלת בפרקטיקה פרטית בילדים, בני נוער ומבוגרים .יועצת ארגונית ב'צפנת' – מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני. מרצה באוניברסיטה העברית בבית הספר למדיניות ציבורית ובביה"ס לחינוך במגמה החינוכית-קלינית של הילד.

חשיבה טיפולית במסגרת חינוכית: מתח והשלמה ברמה קלינית וארגונית

התחבטויות קליניות וארגוניות:

באחד מהמהלכים המכוננים בחיי המקצועיים, שהתרחש בראשית דרכי, עמדתי מול הסוגיה הבאה: עבדתי אז בשנה הראשונה כמתמחה בפסיכולוגיה חינוכית בבית ספר יסודי. הצוות הציג בפני את נ. שסבל מקשיים התנהגותיים רבים. סופר לי כי המשפחה מוכרת לצוות החינוכי מזה שנים, וכי ישנה השערה שהילדים בבית חשופים להתנהגות אלימה של האב. הצוות טען כי לאורך השנים נעשו נסיונות לערוך התערבויות שונות עם ההורים ואף לערב פקידת סעד, וכולם עלו בתוהו. לא רק שההורים לא שיתפו פעולה עם גורמים מקצועיים (ואלה מצידם לא הפעילו את החוק), אלא אף התנגדו לכל מעורבות פסיכולוגית ישירה עם הילד. באותה עת קיבלתי את התפיסות הללו כנתון שלא ניתן לשנותו אלא לעבוד עימו, ונרתמתי ברצון לסייע לצוות באמצעות תהליך של קונסולטציה למורה. למעשה, יש לי זכרון קלוש ביותר בנוגע להתערבויות הספציפיות שייעצתי לצוות לנקוט בהן, אך אני זוכרת, כי במהירות יחסית חל שינוי משמעותי בהתנהגותו של נ. אך למרות האפקטיביות של תהליך ההתערבות, מצאתי את עצמי מתחבטת הן בנוגע למשמעות הפנימית של המהלך עבור נ., והן עבורי כפסיכולוגית מתחילה, העובדת בתוך מסגרת חינוכית.

לא הסתפקתי בטיעון המקובל, כי שינוי התנהגותי מסייע ליצירת דפוסי אינטראקציות חדשים ביחסה של הסביבה לנ. זאת למרות שקרוב לוודאי אכן הודות לשינוי, נ. עורר אמפטיה בסביבה, וזכה ליחס יותר תומך וקרוב, בהשוואה להתנהגותו המתריסה הקודמת, אשר הרחיקה ממנו מקורות תמיכה. חשבתי כי בהנחה שהצוות צודק בנוגע ללחצים בהם נתון נ. בביתו, הרי שהשינוי הסימפטומטי יצר מצב בו מציאות החיים החיצונית כבר איננה מבטאת את מציאות החיים הפנימית של נ. במובן זה הסימפטום הקודם לא רק שהיווה עדות מתמדת או ביטוי לזעקת מצוקה מתמשכת, אלא גם גילם באופן פרדוכסלי הלימה בין שני מישורי חייו – החיצוני והפנימי. תהיתי האם הסרתו יוצרת תהליך של דיכוי רגשי. מעבר לדיון שהתנהל בתוכי אודות משמעותו הסימבולית של גלגולו של הסימפטום, עלתה בי אי נוחות רבה בנוגע להצטרפות המהירה שלי לאג'נדה הגלויה והסמויה של הצוות החינוכי, ומצאתי את עצמי מנסה לזהות את הלחצים שהופעלו עלי לשותפות זו, תוך שאני יוצרת לעצמי נרטיב של 'מטרות משותפות'– של הצוות החינוכי, של הילד ושלי, כדמות מטפלת במסגרת חינוכית.

סוגיות הנוגעות להזדהות ומובחנות של אנשי טיפול העובדים במסגרות חינוכיות (יועצות, מטפלים בהבעה ויצירה ופסיכולוגים) לעומת הצוות החינוכי, מעסיקות כל דמות טיפולית הנמצאת במוסד חינוכי. הפרופסיות השונות בחרו באופן מסורתי בהתמקמות שונה על הרצף של הזדהות-מובחנות. כך למשל, אנו נוטים לרוב לראות את היועצות, כממקמות את עצמן באופן שיתופי יותר (מה גם שלרוב בנוסף לעבודתן הייעוצית הן מהוות חלק אינטגרלי מהצוות החינוכי בהיותן עוסקות בהוראה באופן ישיר), ואילו המטפלים באומנויות והפסיכולוגים מסמנים את עצמם לרוב כמובחנים יותר. במקביל, אלה האחרונים פעמים רבות האחרונים נתפסים על ידי צוותים חינוכיים כזרים (ואף כמתנשאים) או כמי שאינם מבינים את עוצמת המצוקה שהצוות החינוכי נתון בה מול קשיי ההסתגלות השונים של הילדים וההשתמעויות הנלוות לכך.

השאלות עימן מנסה אם כן לדון מאמר זה הינה פנים פרופסיונליות ובין מקצעיות. הראשונה, עוסקת בנושא ההגדרה העצמית – **במה עוסק איש הטיפול העובד בתוך מסגרת חינוכית, מהי המשימה המרכזית שלו, ומהם המושגים**

התאורתיים המוצעים ככיוון דרך להגדרה זו. הסוגיה השנייה קשורה לשאלת המפגש הבין מקצועי. בהקשר זה נשאל, מהי סוג השותפות הנבנית בין הצוות החינוכי לדמויות טיפוליות? מהם הכוחות והלחצים המופעלים על הדמות הטיפולית (להלן, בקיצור – המטפל) בעיצוב מקומו המקצועי בתוך הארגון הבית ספרי, וכיצד הוא מצידו משפיע על הגדרת העבודה של סובביו. ובהקשר זה גם נשאל, מהי המשמעות של תנועה משותפת – חינוכית וטיפולית, וכיצד אנשי המקצוע השונים יכולים לפעול באופן משלים?

אקדים ואציין כי הנחת היסוד של מאמר זה הינה שהגדרה מקצועית איננה משתנה סטאטי (ראה גם קטן וסאנג, 1984). הגדרות וסימוני טריטוריה אפשריים בדיונים תאורטיים בלבד (אופנהיימר ובנימיני, 2001, טליאס 2009). במציאות ארגונית גבולות הופכים להיות דיפוזיים וניתנים לחדירה ללא הרף. אך דווקא משום כך חשוב מאוד שלמטפלים עצמם יהיו נקודות התייחסות ברורות יחסית בנוגע לאתיקה של עבודתם, כך שגם חילופי תפקידים, התערערות תחת 'התקפות' וכו' יוכלו להיות מובנים דרכם. כמו כן, חשוב להציע כי סוגיות הנוגעות להבדלים בין מוקדי העבודה השונים יהוו כשלעצמם מושא לדיונים בין מקצועיים.

עמדה חינוכית ועמדה טיפולית:

כבסיס לאבחנה בין כיווני הבנה ופעולה מקצועיים שונים ברצוני להציע את האבחנה בין עמדה חינוכית-הסתגלותית לעמדה טיפולית-רפלקטיבית. אבחנה זו מבוססת במידה רבה על קווים שהציעה מנוני בספרה (1993), אך איננה מקבילה באופן מלא להמשגה שהוצעה על ידה.

על פי ההגדרה המוצעת, **העמדה החינוכית הינה עמדה המתעניינת בעיקר בהסתגלות של הפרט למשימות הנתפסות כנורמטיביות,** ובהקשר הבית ספרי – הנתפסות כמותאמות עפ"י קבוצת בני הגיל. הנורמות יכולות להיות קשורות **למשימה הבסיסית של בית הספר** – למידה, כאשר המיקוד הינו ברמת התיפקוד של התלמיד מבחינה גרפו-מוטורית, חשבונית, קריאה כתיבה, או ברכישת ידע בתחומי התוכן השונים. תחום תיפקודי מרכזי נוסף בחיי בית הספר לגביו ניתן להחיל נקודת מבט חינוכית-הסתגלותית הינו **התחום ההתנהגותי** – היכולת של הילד להבין נורמות התנהגות ולפתח מיומנויות למידה (יכולת לשבת לאורך זמן, הבאת ציוד רלוונטי, התארגנות עם משימות השונות עפ"י לוח זמנים יומי, או תקופתי ועוד). ת**חום תיפקודי נוסף הינו חברתי** – היכולת לפעול עפ"י קודים חברתיים כללים, כגון, המתנה בתור, שמירה על הדדיות בשיחה, וויסות התנהגות תוקפנית, או בהתאם לניואנסים המאפיינים תת-תרבות, כגון, התאמת סוג הומור, שימוש בסלנג, מחוות גוף וכד'

בהגיון הפנימי של העמדה החינוכית-הסתגלותית השתנות נמדדת עפ"י קריטריונים אובייקטיבים, כלומר, עפ"י מדדים הניתנים לצפייה ולהסכמה בין הצופים השונים. למשל, בזיקה לשלושת תחומי התיפקוד שהוזכרו לעיל, ניתן לבחון את רמת ההישגים (של התלמיד/הכיתה/ פלח אוכלוסיה וכד') עפ"י מבחנים משווים (כגון, מבחני מיצ"ב), המידה בה הילד נענה לדרישות המורים כיום לעומת העבר, מידת המותאמות של התלמידה לנורמות החברתיות של בני כיתתה וכד'. למעשה, כל אותם מושאי חקירה של שיטות המבוססות ראיות (evidence based) מתייחסים לאותם אספקטים תיפקודיים הניתנים לכימות ולמדידה.

לעומת זאת, **העמדה הטיפולית במהותה חוקרת ומתעניינת בעולם הפנימי של הפרט הקבוצה או הארגון.** בהקשר זה הקליינט כפרט יכול להיות התלמיד/ה או לחילופין המורה/המנהלת וכו', והקליינט כקבוצה יכול להיות הכיתה או לחילופין צוות מקצועי מוגדר, ואילו הקליינט כארגון יכול להיות בית הספר או למשל מערכת חינוך ברשות מקומית נתונה. בעמדה הטיפולית ישנה חתירה להבין את המשמעות שמייחס הפרט (או הארגון) לאירועים המתרחשים והרלוונטים עבורו. העולם הסובייקטיבי הוא העומד במוקד החקירה של העמדה הטיפולית. חשוב להבחין כי תחת ההגדרה המוצעת כאן, החקירה של הסובייקטיביות איננה בהכרח מתמקדת בעבר ו/או בלא מודע,

אם כי יכולה גם להתעניין בכך. חקירה זו יכולה להיות ממוקדת בפרשנות או במשמעות שהפרט (או הקבוצה או הארגון) מייחס לאירועים /משברים העוברים עליו, ברגשות המתלווים לכך, בסיבות שהוא מייחס לאירועים, בכוונות שלו בנוגע לעתידו וכו'. במובן זה כמובן החקירה של התאוריות הפסיכואנליטיות, על גישותיהן המגוונות, נופלות ללא ספק תחת כיוון זה של מבט, אך גם תאוריות מערכתיות כדוגמת זו של מייקל וויט (1990), או תאוריות נרטיביות, המכוונות ליצירת סיפור החיים של הפרט (או הקבוצה).

כמובן ששינויים במישור הסובייקטיבי עשויים להיות מלווים בשינויים התנהגותיים. למשל, ילד שתפס את עצמו בעבר כמי שאין לאף אחד כוח בשבילו ואת הסביבה כמנוכרת וזרה, והגיע לתובנה שהחזרות האינסופיות שלו על עצמו מעוררות בסובבים תגובות של המנעות מקשר עימו, עשוי בעקבות תובנה זו לרסן את החזרתיות. דוגמא נוספת, צוות שבעבר חווה את עצמו כנתון במחלוקות פנימיות הפוגעות ביכולת לעבוד באופן פורה, מביע לאחר זמן רצון להשקיע מאמצים ומשאבים בבירור וליבון אי הסכמות על מנת להתפנות בהמשך לסוגיות מקצועיות-ענייניות. לשינויים ברובד הסובייקטיבי עשויים להיות גילויים התנהגותיים, נתמכי ראיות, הניתנים למדידה אובייקטיבית-מוסכמת, אך אלה עפ"י ההגדרה המוצעת כאן אינם במהות ההתעניינות הטיפולית, גם אם הינם לעיתים הדרך באמצעותה ניתן להווכח בהשתנות או בהיעדרה.

דוגמא: ר. נמנע מביצוע מטלות גרפו-מוטוריות. מהפרספקטיבה של עמדה חינוכית נתעניין בקצב התקדמות ההענות שלו לאימונים, וכמובן גם בהישגיו הממשיים בכתיבה לאורך הזמן. מנקודת מבט טיפולית נשאל, מהי החוויה של ר. אודות המשימות והדרישות המוצגות בפניו – האם חווה את העזרה המוצעת לו כמסייעת פוטנציאלית? האם חווה אותה כהתקפה? מהי עוצמת העלבון המתלווה מבחינתו לעיסוק במשימות בהן מתקשה? האם חווית העלבון מוכלת או נחווית על ידו כמציפה? אנו כמובן נניח כי אם יהיה שינוי בעמדה הפנימית של ר. ביחס למשימה וביחסו להיותו נזקק לסיוע, יהיה לכך ביטוי שיתרחש גם במישור התיפקודי. יחד עם זאת, לא נוכל להניח שהשתנות במישור אחד מצביעה בהכרח על השתנות במישור אחר. כלומר, שהשתנות בתיפקוד מצביעה גם על שינוי בעמדה פנימית, או ששינוי בתפיסה של העצמי או של הסביבה יוביל בהכרח לשינוי התנהגותי (ראה גם אוסטרוויל, 1995). בדומה לכך, שינוי התנהגותי אינו יכול להעיד על מידת ההשתנות הפנימית שאירעה. האם ר., שמוכן כיום יותר להתאמן בכתיבה עושה זאת, משום שתחום הגרפו-מוטורי מעורר בו פחות חרדה? האם פחות מאויים מחוייה של אי מסוגלות/קושי? או שמא נענה מתוך עמדה של מובסות אל מול עוצמת הלחצים והדרישות החיצוניים או בשל סיבה אחרת. חשוב להכיר בכך, שלא ניתן לדעת על הסובייקטיביות ללא חקירה ישירה או עקיפה (באמצעות חומר השלכתי) של הסובייקט!

עפ"י ההגדרה המוצעת לעיל, העיסוק בחלק ניכר מהמקצועות המכונים כיום 'טיפוליים', כגון ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת הינם ביטוי לעמדה חינוכית בהיותם עסוקים בהיבטים התיפקודיים של הילד/ה. ברגעים בהם המטפל עסוק בשאלה של הסובייקטיביות של הילד (מה הוא אוהב/שונא/נהנה/נרתע לתרגל, כיצד מרגיש ביחס למשימות הנתבעות ממנו, מהי עוצמת תחושת אי הנעימות וכד', הוא מגלה עמדה טיפולית. בדומה לכך, רוב החלקים באיבחונים הפסיכולוגיים עוסקים במידה רבה בהיבטים ההסתגלותיים (למשל, בהשוואת תיפקוד אינטלקטואלי בהשוואה לבני הגיל), ומבטאים עפ"י ההגדרה המוצעת כאן, עמדה חינוכית. לעומת זאת, החלקים (בראיון או במבחנים השלכתיים) בהם ישנה חתירה לחשיפת האופן בו תופסת הילדה את עצמה את האחרים ואת היחסים בניהם, מבטאים עמדה טיפולית.

הנחת היסוד של מאמר זה הינה ששתי העמדות – החינוכית והטיפולית מובחנות זו מזו בתחומים קריטיים: **ראשית, שתיהן אינן מתעניינות באותו אובייקט. שנית, כל אחת מהן חותרת ליעדים שונים, ושלישית, הן מבוססות על פרקטיקות שונות.** יחד עם זאת, ההנחה היא ששתי העמדות מקיימות בניהן **יחס קומפלמנטרי,** כלומר, שתיהן

חיוניות להתפתחות נפשית תקינה, וקיומן זו בצד זו מהווה השלמה חיונית. עם זאת, כדי שיהיה ניתן לקיים את שתיהן, לנוע בין שתיהן, ולהבחין בדיספרופורציה של היחס בניהן (השתלטות של עמדה חינוכית על הצורך לתת הכרה לחוויה, או להיפך) חשוב להבחין בין השתיים. ההבחנה איננה רק עניין לסוגיה פנים מקצועית – הבנה של אנשי פרופסיות טיפוליות את מהות עבודתם, אלא גם סוגיה ארגונית. שכן בהקשר של מפגש בין מקצועי מתעוררים במהרה דינמיקות ודפוסים של יחסי כוח (גם אם לא מודעים בחלקם) בין גורמים תת-מערכתיים שונים, המשפיעים על האיזון בין השתיים. בעניין זה אדון בהמשך המאמר. כמובן שכולנו, אנשי מקצוע חינוכיים וטיפוליים, מעוניינים בהתקדמות של הילד מבחינה נפשית ובהסתגלותו התקינה לתנאי המציאות, אך בתרגום של מטרה כללית זו לכיווני חקירה ופעולה שתי העמדות כאמור חותרות ומכוונננות להיבטים נפשיים שונים.

אובייקט טרנספרנסיאלי ואובייקט התפתחותי:

כבר מראשית ימי הפסיכואנליזה היתה הכרה בשתי עמדות מהותיות שונות. בגילויים שונים קיבלו את הכותרת כמתח בין doing ל being, או בין פירוש לסיפוק. העמדה הדומיננטית שהתפתחתה החזיקה בתפיסה כי המשימה הפסיכואנליטית המרכזית הינה להפוך את הלא מודע למודע באמצעות פירוש. התובנות, אם כן, ולא הפעולות, של המטפל הן כלי עבודתו המרכזי של המטפל. **המטפל כאובייקט טרנספרנסיאלי**, מעמיד את עצמו כמושא להשלכות המטופל, ופעולתו העיקרית הינה לחשוף ולפרש את הרבדים הלא מודעים שבתכניו או בדפוסי הקשרים החזרתיים שהמטופל יוצר (Hurry, 1998,מיטשל, 2006). אנה פרויד (1965, 1976) היתה בין התאורטיקנים הראשונים שהציבו סימן שאלה בנוגע להתאמה של עקרונות הפרקטיקה הפסיכואנליטית, שפותחו במקור בקונטקסט של טיפול במבוגרים – הפיכת הלא מודע למודע באמצעות פירוש - עבור טיפול בילדים (ובעיקר התאמתם לטיפול בילדים שעברו טראומות). עבור א. פרויד המטרה הטיפולית המרכזית היתה הרחבת אזורי המודעות והגדלת שליטת האגו, וטענתה היא, כי על מנת להגיע לכך יש צורך לנקוט בהתערבויות אשר אינן בהכרח פרשניות. במאמרה הביקורתי על הפרקטיקה הפסיכואנליטית (Freud A., 1976) כינתה את גישתה 'בונת אגו' ('ego building approach'). א. פרויד הבחינה ב ב"מרכיבים טיפוליים משניים", המשפיעים לטובה במקרים שאינם נוירוטים – הצעות, אישורים, המללה של רגשות, הבהרות בנוגע לסכנות חיצוניות ופנימיות, הכוונה לשלוט על משאלות ודחפים במקום לפעול על פיהם, הדרכה לתקשר עם אחרים ולראות אותם כבעלי מחשבות ורגשות מובחנים ועוד. (מוקדים אלה באינטראקציה בין המטפל למטופל זוהו כפונקציות המתרחשות ביחסי הורים-ילדים, והוגדרו באופן ממוקד יותר בתחום תצפיות על תינוקות. ראה Hurry, 1998).

בכתיבה הפסיכואנליטית (ולא רק בתחום הטיפול בילדים), נערכים נסיונות להכליל פונקציות התערבותיות אלה בתוך המסגרת הטיפולית, והוצע לראות את המטפל בהקשרים האלה כ**'אובייקט התפתחותי'**, כלומר, כדמות המספקת הכרה אמפטית, המשלימה צרכים התפתחותיים שתוסכלו או נעצרו. חשוב לציין כי השינוי הפרדיגמטי בתפיסת הפונקציות הטיפוליות המוכרות והחיוניות, עדיין מותיר את בעלי גישה זו בתחום הפסיאנליזה הקלאסית, שכן נשמרת האבחנה בין סיפוק צורך התפתחותי לבין סיפוק ייצרי. בהתאם לכך, המטפל במידת הצורך מרחיב את מנעד ההתערבויות הקלאסיות כאשר הוא, למשל, מזהיר את המטופל-הילד מתוצאה שלילית של תגובותיו, מעודד אותו להתגבר ולהתמודד עם קושי (לימודי/חברתי וכד'), מציע לראות את החבר/ההורה מנקודת מבט אחרת, במקרה של עימות וכו'. יחד עם זאת, המטפל נזהר שלא לספק צורך בחברות, במגע, בהערצה וכד'.

לאור האבחנה המושגית המוצעת לעיל, נוכל לחזור לנושא המאמר הנוכחי ולטעון כי הסביבה החינוכית של הילד, כאשר היא ממלאת את תפקידה באופן מיטבי מציעה את עצמה כאובייקט התפתחותי במובנו הרחב. כלומר, הצוות

החינוכי אינו רק אמון על יחסי הוראה והדרכה אלא מייצר גם יחסים שיש בהם התייחסות להיבטים המחזקים את כוחות האגו של הילד – שליטה, איפוק, ריסון, תכנון, ארגון וכד'. עם זאת, בנוסף לאחריות החינוכית-התפתחותית שהצוות לוקח על עצמו, המטפל, העובד בתוך/עם מסגרת חינוכית יכול לעודד את הצוות החינוכי להיות ער לאספקטים טרנספרנסיאלים שברצונו או לא ברצונו מושלכים עליו.

דוגמא: ע. ילד אינטלגנטי בן 10, סובל מבעיות התנהגות שונות. הצוות בנה תוכנית התנהגותית, ומחזק אותו על התנהגויות לימודיות חיוביות. לאחר זמן המורה דיווחה לפסיכולוג ביה"ס כי לא רק שע. אינו נענה לחיזוקים שלה, אלא אף כאשר היא משבחת אותו, למשל כאשר הצליח להתאפק ולאסוף כוחות לביצוע מטפלות לימודיות, פעמים רבות תגובתו המיידית הינה שלילית – מפסיק לתפקד, ואף מגביר את התנהגותו התוקפנית כלפיה וכלפי ילדים אחרים. עלתה השערה כי בתגובתו השלילית (והמנוגדת לציפיות) ליחס חם ותומך, מבטא ע. הפנמה של ייצוג שלילי של יחסים, למשל, אי אמונה שיחס מיטיב יכול להשאר לאורך זמן, ולא להתקלקל. כמי שמחזיק בדפוס כזה של יחסים, ע. מעדיף להיות מי ששולט במצב, כך שלפני שהאחר יקלקל, הוא עושה זאת בעצמו... וממהר 'להרוס' כל מחמאה או גילויים של חיבה וקירבה. בעקבות השערה זו, עלה רעיון מתוך השיחה המשותפת, כי המורה תקבל את רצונו לשלטו על הסיטואציה, ותבקש את רשותו להחמיא לו, לפני שעושה זאת בפועל...

כפי שחשוב שהצוות החינוכי יכיר גם באספקטים סובייקטיביים ובפרשנות הייחודית שמעניק הפרט למתרחש, כך גם חשוב שהמטפל יהיה מסוגל לנוע בהתאמה לצרכי הילד (המשתנים) בין הקוטב הטרנספרנסיאלי-מפרש, לבין ההתמקמות כאובייקט התפתחותי. דוגמא: בבית ספר יסודי מתקיימת קבוצה טיפולית בהנחיית פסיכולוגית בית הספר ומטפל בבע"ח. המטפלים, המחוייבים למשימה הטיפולית, מזמינים את הילדים להשליך תכנים פנימיים על בעה"ח (כגון, פחד להתקרב, משאלה להיות מלוטף, כעס על חיה אחרת וכד'), ומעודדים את הילדים לשתף בתחושותיהם ביחס לאינטראקציות המגוונות בין חברי הקבוצה ובינם לבין המנחים. בנוסף למוקדים אלה של התערבויות, המטפלים עשויים להדרש גם להתערבויות בעלות משמעות התפתחותית-חינוכית, למשל, להסביר כיצד לא להכאיב לחיות, לדרוש איפוק בנוגע לתגובות מסויימות, ואף לשים גבול כאשר ילד מתנהג בתוקפנות מוגזמת כלפי בע"ח.

כאמור, חשוב להכיר בחשיבות שתי העמדות, ובחיוניות של שתיהן לצורך התפתחות כוללת תקינה. מתוך הפריזמה הקלינית ניתן לראות את הפעולה המשלימה של שתי העמדות כתנועה בין התמקמות המטפל כאובייקט טרנספרנסיאלי להתמקמותו כאובייקט התפתחותי, וכל זאת בתוך מסגרת המפגש הטיפולי. לעומת זאת, בהקשר המערכתי האחזקה בשני היבטים חיוניים ומשלימים אלה יכולה ל**התחלק בין הדמויות השונות** הנושאות אחריות כלפי הילד.

עמדה טיפולית כחתירה להרחבת היכולת 'לשחק עם המציאות':

כדי להרחיב את ההבנה סביב החשיבות של התנועה המשותפת של שתי העמדות – החינוכית-הסתגלותית והטיפולית-רפלקטיבית, נוכל להמשיך ולהסתייע בהשראה מושגית שפיתחו פונגי וטרג'ט. בסידרה של מאמרים משנת 1996 הם מתארים את החשיבות של היכולת לשחק עם רעיונות כיכולת קריטית בתהליך ההתפתחות. בפראפרזה על ספרו של ויניקוט Playing and Reality, הם טוענים כי היכולת לשחק עם המציאות (Playing with Reality) עומדת בבסיס התפתחות היכולת **למנטליזציה** –האפשרות לראות את העצמי כבעל רעיונות, כוונות ורצונות, ואת האחר ככזה, ולפיכך כמי שיכול להיות שונה ואחר מהעצמי. בראשית החיים (לפני גיל 4-5), ובפגיעות ראשוניות (בעקבות טראומות קודמות) יכולת זו נפגעת. הפעוט או לחילופין המטופל הפגוע באופן טראומטי אינם מצליחים לראות את המציאות הפנימית כשונה מהמציאות החיצונית (פונגי וטרג'ט מכנים מצב מנטלי זה - mode of

equivalence). כך למשל, הילד כאשר הוא נמצא במצב של העדר מנטליזציה, רואה שני ילדים משוחחים, ומסיק, שלא רק שהם מדברים עליו, אלא שהם בוודאי לועגים לו. החוויה הפנימית היא של וודאות, וקושי להעלות על הדעת אופציה אלטרנטיבית. תלמידה מצטיינת שחוזרת ומשננת לקראת כל מבחן את החומר אינספור פעמים, ומבקשת מהסובבים בבית ובבית הספר לחזור ולשאול אותה על החומר, חשה כי רק סוג כזה של טקס למידה יבטיח שתצליח במבחן, משום שזו היתה הדרך בה נהגה במקרים הקודמים – והצליחה. כל אפשרות להבנייה שונה של תהליך הלמידה, מעוררת בה אי שקט גדול, ודחף רב עוצמה לחזור למתכונת המוקדמת (מבטיחת ההצלחה מבחינתה).

דוגמא נוספת: ב. תלמיד חינוך מיוחד, המשולב בבית ספר רגיל. אימו רוצה להוציאו מהמסגרת הנוכחית ולהעבירו למסגרת של חינוך מיוחד, משום שמרגישה שב. נמצא בלחץ אדיר להשתלבות, דבר שמעורר בו תחושות של נחיתות ואי הצלחה תמידיים. המרפאה בעיסוק יצרה קשר טלפוני עם האם, ובהתרגשות רבה אמרה לה, כי למיטב התרשמותה בית הספר עדיין לא מיצה את האפשרות לסייע לב., וכי סבורה שכדאי להשהות את ההחלטה למשך מספר חודשים. הוסיפה ואמרה כי מאמינה בב., ורואה את היכולות הגלומות בו. אימו של ב. הגיבה בזעם אדיר, ואף איימה בתלונה לפיקוח על 'חוסר המקצועיות' של המרפאה בעיסוק. ניתן לראות כיצד המפגש בין השתיים עורר מקומות של פגיעה במנטליזציה אצל שתיהן. האם, לא יכלה שלא לראות את ההצעה של המרפאה אלא כפגיעה וערעור על שיקול הדעת שלה, ועל היותה אם אופטימלית המחפשת את הטוב ביותר עבור בנה. מצד המרפאה בעיסוק נראה (עפ"י תובנה שלה עצמה שלאחר מעשה), שלא יכלה לשאת את המחשבה שבית הספר והצוות הרב מקצועי לא הצליחו לקדם את הילד חרף כל השקעתם המתמשכת. היא הרגישה שהם '**חייבים** לקבל הזדמנות נוספת', כך שעזיבתו לא תלווה במשמעות של כישלון. יש לדייק כי לא כל פרשנות שלילית של אירוע מצביעה על העדר המנטליזציה, הביטוי לפגיעה זו הוא בהעדר היכולת (באופן זמני או קבוע) לראות את המציאות מנקודת מבט חלופית. הפרט או הקבוצה (למשל במצבים של שעיר לעזאזל) או הארגון (במצבים של עימות בין צוותים) משוכנע, שלא יתכן שהמציאות שונה מכפי שהוא רואה אותה.

במובנים רבים ניתן לראות מצבים של תקיעות נפשית כמצב של mode of equivalence, המאופיין בתפיסה חד מימדית של המציאות, ובתחושה שהתפיסה של המציאות והממשות חד הם. לעיתים המטפלת/המחנכת מזדהים עם תפיסת הילד, או שגם אם אינם מזדהים עימו, הם מתקשים לשמור על תפיסה אלטרנטיבית. דוגמא: ד. נער בכיתה י', שכל את אחיו. בתקופה שלאחר האובדן התיפקוד הלימודי וההתנהגותי שלו נפגעו באופן ניכר. במקרה זה הן הצוות החינוכי והן המטפל, מתוך עמדה שראו בה אמפטיה כלפי עוצמת תחושת האובדן, הניחו כי האבל על המוות כה עצום, עד כי נ. אינו פנוי ללמידה. עמדה אמפטית ללא מסוייגות זו מנעה מהם לבחון אופציות נוספות של משמעות הפגיעה התפקודית. למשל, תחושת אשם ('אשמת ניצולים') של הילד המעוררת התנהגות הרסנית, של פגיעה עצמית, ומשקפת אופן של הענשה עצמית. אפשרות נוספת היא שד. דווקא מרגיש בתוכו רצון ואף כוחות (גם אם מוגבלים לעומת העבר) לחזור לחיים ולתפקד באופן נורמטיבי, אך מרגיש שהסביבה מצפה ממנו לא לשכוח, ובמובן זה התנהגות רגילה תתפרש, על פי תפיסתו, כמעוררת בושה, וכן חזרה מהירה יחסית לשיגרה, תצביע על כך שכביכול לא הושפע עמוקות ממותו של האח.

כדי לשמר את האפשרות למנטליזציה ביחס לתלמיד/למטופל ולהחזיק באפשרות לראות אותו באופנים נוספים, יש צורך במבוגרים נוספים שיחזיקו בחלקים של הילד שהמורה, או לחילופין המטפלת אינם יכולים להחזיק ברגע נתון. בעבר טיפלתי בש. בת לאם שעברה התעללות מינית בילדותה. ש. הופנתה ע"י הוריה בשל קשיים חברתיים מתמשכים. ובפגישות נהגה לתאר לי כיצד ילדי הכיתה מתעלמים מנוכחותה, מסרבים או מתחמקים מלשתף אותה במשחקים או מביצוע משימות לימודיות, זאת למרות שש. הינה תלמידה טובה מאוד, והיו יכולים לשאת נישכרים מצירופה לקבוצתם. חודשים ארוכים מצאתי את עצמי מזדהה עם סיבלה של ש. סביב חווית הנדחות, ועם הכעס

שחשתי שהולך והגואה בי כלפי ילדי הכיתה על אכזריותם, ועל הצוות החינוכי שאינו רואה את הדינמיקה הקשה המתפתחת מתחת לאפו. לאחר זמן שוחחתי עם המורה, והיא מצידה סיפרה לי על מאמציה הרבים לשלב את ש. בכיתה, וכיצד זו מצידה מחבלת בכל נסיון. עפ"י הסיפור שלה גם הילדים בכיתה מגוייסים לתהליך זה, אך היא מתרשמת כי אט אט הם מתעייפים מהדחייה של ש. את הזמנותיהם, ושומטים אותה. בעקבות השיחה עם המורה הבנתי את ההתנהגות של ש. כנטייה קורבנית ליצר את עצמה כחלשה ופגיעה (ו'צודקת'...) ואת הסביבה כתוקפנית. בשלב זה של הטיפול לא יכולתי לעמת את ש. עם המציאות, שכן כל הצגה של האפשרות שהיא איננה קורבן, היתה מעוררת בה אך ורק זעם כלפיי. עם זאת, באופן מנטלי התחלתי להחזיק אותה באופן שונה בתודעתי, זאת גם מבלי שיכולתי במשך תקופה ארוכה לבנות התערבות פרשנית אלטרנטיבית, דבר אשר בהמשך באופן הדרגתי התאפשר.

מנוני (1993) קובעת כי התפקיד של המטפל הינו תמיד ליצור סוג שיח שבו ישנה חתירה לפענוח המשמעות הסימלית של פעולותיו או דבריו של הילד. כך למשל, נאמנה לתפיסה הפסיכואנליטית (הקלאסית) מנוני טוענת (דברים אשר מעוררים כיום עמדה אירונית, אם לא צינית, ומקוממים אנשי מקצוע רבים – ולא רק מתחום החינוך) כי אם לילד ישנם קשיים בתחום החשבוני, המטפל יתבונן על הקושי לחבר בין מספרים כמבטא באופן סימבולי קושי בחיבור בין אנשים וקושי עם קירבה. העמדה החינוכית העכשווית תתבונן על קשיים חשבוניים מן ההיבט הנוירולוגי – כביטוי ללקות למידה, ובלשונה של מנוני תתעניין בהיבטים הקונקרטים של התופעה – הקושי הוא מה שקשה (ולא מה הוא מייצג). לאור הדברים ברצוני להציע אופציה שלישית שיכולה לכוון את התמקמות המטפל בתוך מסגרת חינוכית. לא עמדה הרואה בדברים הממשיים את האפשרות היחידה , כלומר לטפל בלקות אך ורק כקושי ממוקד, ואף לא עמדה הרואה בקשיים סימון סימבולי של תכנים אחרים, **אלא מיקוד באופן בו הילד מתמודד עם הלקות כביטוי לסיפור שהילד מספר על האופן הו הוא תופס את העולם, וחווה את הסביבה כתופסת אותו.** המשמעות של עמדה טיפולית והתערבות טיפולית הינה הרחבת מרחב המשחק – הן של הילד ביחס לעצמו והן של הצוות החינוכי וההורים ביחס אליו והן בייצוג של היחסים בין כל הגורמים הנ"ל. מטפלים רבים עובדים כך הלכה למעשה, ובדבריי אין עבורם חידוש בנוגע לפרקטיקה, אלא באפשרות להמשגת עקרונות המנחים את העבודה הטיפולית.

דוגמא: א. נער בן 16 הסובל מ PDD (לקות על הציר האוטיסטי), לומד בכיתת תקשורת בבית ספר רגיל. א. סובל בנוסף לליקויים בתקשורת גם מליקויי למידה נוספים, ולפיכך למגינת ליבו אינו יכול להשתלב במקצועות לימוד רבים בכיתה ה'רגילה'. א. שרוי בשל כך בלחץ רב, בחוויה שלו, אם לא יהיה עם תעודת בגרות מלאה הוא יהיה "מנקה רחובות או הומלס". כל הנסיונות של הוריו ושל הצוות החינוכי להרגיעו ולהרחיב את תפיסת העתיד עלו בתוהו. ניכר היה שא. רואה את עצמו חי ברחוב, ומבחינתו לתסריט הפנימי הזה יש עוצמה ממשית מאוד, כאילו הדבר עומד להתרחש. במקביל, א. התנהג באופן פוגעני כלפי הצוות, בכך שנהג באופן חוזר ונשנה לומר להם כי רוצה לעבור לבי"ס אחר, שם לטענתו יסייעו לו יותר. הצוות חווה אמירות אלה ככפיות טובה ואי הכרה במאמציהם הרבים לקדמו. המטפל הסביר לצוות כי א. שחש חסום מבפנים משליך את חווית המחסום על הצוות. בפנטזיה של א. הצוות (ולא הלקויים שלו) הוא המונע ממנו מלהחלץ מגורל של מנקה רחובות, וא. היה רוצה להאמין כי לו היה לומד בבית ספר אחר, היה מצליח להגיע להישגים נורמטיבים יותר. בשיחה משותפת עלה הרעיון כי תוצג בפני א. אלטרנטיבה השגית – תעודת סיום 12 שנות לימוד. הישג זה, כך הודגש, יוכל לפתוח בפניו אפשרות להשתלב בקורסי הכשרה שונים בעתיד, גם אם לא במסגרת אקדמית. נראה כי הפירוש אודות ההשלכה שעושה א. בשילוב עם הבנייה של מטרה מחודשת יצרו רגיעה מסויימת. כלומר הן הצוות והן א. עברו תהליך של הרחבת היכולת לשחק עם המציאות.

'משחק' עם העמדות:

כאמור, העמדות המוצגות לעיל מבוססות במידה רבה על אבחנה שעורכת מנוני (1993). מנוני, פסיכואנליטיקאית, עבדה בצרפת שנים ארוכות במוסדות לילדים עם קשיים קוגניטיבים ורגשיים חריפים, ועסקה בסוגיות הנוגעות לתנועה המשותפת בין גורמים חינוכיים וטיפוליים. על פי הגדרתה העמדה החינוכית, 'מאורגנת סביב המציאות הממשית של הילד', ואילו עמדה האנליטית נשענת על חקירה של הייצוג הפנימי. יחד עם זאת, מנוני מייחסת באופן חד משמעי עמדה חינוכית לצוות החינוכי, ואילו את העמדה האנליטית רואה כייחודית למטפלים. הנחת היסוד של מנוני היא כי הטיפול המתקיים בין כותלי בית הספר אינו שונה מהותית בשום אופן מטיפול המתקיים בקליניקה פרטית, פרט לכך שהמטפל מגיע לילדים במקום שאלה יגיעו אליו.

מנסיוני, הגבולות בין אנשי המקצוע השונים בהקשר של הזדהות עם העמדות השונות אינם חד משמעיים, ובניגוד למקובל, אני סבורה כי יש בכך תועלת לא מבוטלת! מורים או מטפלים פרא-רפואיים עשויים בצד עמדה חינוכית, הממוקדת בהסתגלות של התלמיד, להתעניין גם בעולמו הפנימי, ואף להשתמש בפנייתם אליו (באופן אינטואיטיבי או מכוון) בפירושים משמעותיים ביותר. בצד זאת, כמעט כל מטפל בילדים (ונדמה לי שגם הקלאסיים שבנינו) נוקטים מידי פעם במהלך פגישות טיפוליות /ייעוציות בעמדה חינוכית ביחס לסוגיות שונות. כך למשל, אני עשויה ברגע מסויים להשען על הקשר הטוב שיש לי עם מתבגר, שהתפרץ ונתן מכת אגרוף קשה לבת כיתתו, ולומר לו בתקיפות – שלא יוכל לעשות זאת שוב, ולהזהירו כי יש סיכוי שבפעם הבאה שיעשה זאת, יגישו נגדו תלונה במשטרה. באופן מקביל, מחנכת יכולה לומר לתלמיד שמשתמש בהתנהגות סחטנית כדי לגרום לילדים אחרים לחבור אליו, שהיא מבינה שזו הדרך בה נהג להשיג חברים כאשר התגורר בחו"ל, והסתובב שעות רבות ברחובות, אך כעת אין צורך בכך יותר. בהתבסס על ההשראה המושגית שהוצגה לעיל אודות חשיבות היכולת לשחק עם המציאות, הרי שישנה חשיבות רבה ליכולת של אנשי מקצוע שונים לנוע בין העמדות. **כדאי היה שיראו בעמדות אפשרויות תגובה מגוונות, המופעלות בכל פעם עפ"י ההיבט שנראה חסר, ויש חשיבות להשלימו, ולא עפ"י הגדרה פרופסניונלית קבועה מראש.** אני מחזיקה בתפיסת עבודה שאיננה רואה בדמות הטיפולית מי שמקיימת קליניקה בתוך כותלי בית הספר, אלא שותפה למערך התערבותי רחב. ומכאן, שבהערכות ההתערבותית הכוללת חשוב לשמור על איזון בין העמדות השונות, כך שכלל ההתייחסויות הסביבתיות יחזיקו מבט רחב על הילד הכולל הן את ההיבט המציאותי-הסתגלותי של חייו והן את המשמעות הפנימית שמעניק לסיטואציה/ות.

מבט ארגוני - חרדות הדדיות ומאבקי כוח:

לצורך דיוננו ננית כי העמדה החינוכית מהווה משימה מרכזית, גם אם לא בלעדית, של הצוות החינוכי (ובכלל זאת מטפלות בריפוי בעיסוק, קלניאיות תקשורת וכד') ואילו העמדה הטיפולית מהווה מוקד מרכזי בעבודתן של דמויות טיפוליות (יועצות, פסיכולוגים, מטפלים באומנויות וכו'). זאת כאמור מבלי לבטל את העמדה העקרונית שהוצגה לעיל בנוגע לחשיבות המשחק והתנועה בין שתי העמדות בקרב בעלי הפרופסיות השונות. שתי העמדות כאמור, אינן חוקרות את אותו אובייקט ואינן בהכרח מכוונות, לפחות בטווח הקצר, לאותן מטרות. מובחנות זו מהווה קרקע להתפתחות מתחים חרדות ומאבקים, בין אם הם גלויים ומדוברים ובין אם הם סמויים או אף לא מודעים.

מנוני מתארת בספרה (1993) חלק מהקשיים המודעים והלא מודעים המשבשים עבודה בין מקצועית מיטבית. כך למשל לטענתה, המטפל המתמקם כצופה ולא כמכוון מטרה חינוכית, נתפס פעמים רבות ע"י הצוות החינוכי "כמציצן, כמרגל, המזוהה עם מי שמנסה כביכול לגנוב את ה'אובייקט הטוב' " (עמ' 156). נדמה כי כל מטפל העובד במסגרת בית ספרית חווה לעיתים בעבודתו רגשות שליליים (לעיתים לא מודעים) המופנים כלפיו. רגשות אלה עשויים להיות קשורים לתחושות של קנאה – על האינטימיות שמייצר עם הילד, על אי המחוייבות שלו לשתף במתרחש בחדר

הטיפולים הסגור, על אי השתתפותו במשימות הסיזיפיות היומיומיות הבית ספריות (כגון, תורנות בהפסקות), ועוד. סוג נוסף של רגשות שליליים קשור לפנטזיות פרנואידיות של הצוות בנוגע למתרחש בחדר הטיפולים (מה הילד מספר/מתלונן עליה/ם?),

בנוסף, מטפלים רבים חשים לעיתים כי הם מצויים תחת סוגים שונים של התקפה או לחץ. אחד המקורות המרכזיים לכך הוא סובלנות נמוכה למצב של אי ידיעה. בתגובה ללחץ המופעל מצד הצוות החינוכי להבין ולתייג את הקשיים של תלמידים, אנו כדמויות טיפוליות נוטים לעיתים לספק ולהסתפק באבחנה תאורטית של הילד - ADHD , ליקויים בתקשורת ועוד. (וינשטיין ורונן, 2001). בהקשר זה אני מתייחסת **לשימוש ההגנתי באבחנה**, כלומר, לצורך שאנו מרגישים לעיתים **"להגיד משהו בעל משמעות",** זאת במצב בו המשימה הטיפולית המרכזית – חקירת משמעות מצבו של הילד עבור עצמו - איננה מוחזקת על ידי אף גורם בצוות החינוכי, וגם נשמטת ממוקד העבודה היעוצית/הטיפולית. אין כוונתי להטיל ספק עקרוני בצורך באבחנה, כאשר היא מסייעת בהערכות מערכתית ובהשקעת משאבים מותאמים, אלא לרגעים בהם נעשה שימוש ההגנתי-מסיט במתן האבחנה.

סוג נוסף של 'התקפות' קשור לגילויים של תהליכים קבוצתיים, המתרחשים בצוותים חינוכיים כמו בכל קבוצת אנשים עובדת, תהליכים המתעוררים כתגובה לחרדות שונות (Bion, 1961; Gibbard et al, 1974). למשל, לחץ המופעל על המטפל לחבור ללכידות יתר הקיימת בקרב הצוות החינוכי (וינשטיין ורונן 2001). כאשר הקבוצה שומרת על המשימה הבסיסית שלה, היינו מצפים כי הילד, שהינו מטבעו בעל פנים רבות, יעורר תגובות שונות ומגוונות בקרב אנשי הצוות השונים, וכלל תגובותיהם יהווה אחזקה של המורכבות של הילד. במקום זאת, במקרים בהם הצוות עצמו מרגיש מותקף (לא מצליח להתמודד בהצלחה עם הקשיים והאתגרים שהילד מציב) ישנה התייצבות הומגנית ותפיסה אחידה, כאשר במקביל מופעל לחץ רב על הדמות הטיפולית 'לישר קווים'. למשל, נסיונות של המנהל/המורה, לגייס את הפסיכולוג לקראת מפגש עם ההורים לייצג את הלך הרוח בקרב הצוות החינוכי, ולהתאים את עצמו כך ש'נהיה עם קו אחיד ומגובש'.

מקור מרכזי נוסף ללחץ על איש הטיפול הינו להצטרף לעמדת הצוות בכל הקשור למגמות של התייעלות והשגיות בצד מדידות כמותניות, העורכות השוואה בהישגים של תלמידים עפ"י השתייכות כיתתית, בית ספרית וכד'. מגמות אלה מחזקות תרבות ארגונית, הרואה בצעדים 'תכליתיים' ו'מעשיים' את העיקר של העשייה החינוכית, ו'תוקפות' למעשה הוויות אלטרנטיביות דיאלוגיות וחוקרות.

חרדות ופעולות הגנותיות אינן רק מנת חלקם של אנשי צוות חינוכי. נראה כי המטפל חש לעיתים חרדה ביחס לאפשרות שהוא עצמו אינו מכיר את הילד באופן פנימי עמוק יותר מהצוות החינוכי, או לפחות מתקשה לתרגם את מה שרואה או חווה עם הילד לתובנות בעלות פוטנציאל יישומי. לעיתים המטפל חש כי במפגש הטיפולי מתרחש מהלך משמעותי, אך הוא מתקשה ביותר להסביר, ואף לעצמו, את מהותו. לא פעם אני נתקלת בתגובות של מטפלים לסקרנות של הצוות, בנוגע לתכנים שהילד מבטא בטיפול (סקרנות שאיננה מציצנות, אלא רצון כן של הצוות להכיר את הילד באופן מלא יותר), המאופיינות בהמנעות מוחלטת משיתוף, בטענה שהחומר הוא סודי. למיטב התרשמותי, לעיתים המנעות זו נובעת מחרדה מפני חשיפת אי הידיעה של המטפל עצמו בנוגע למתרחש מבחינה טיפולית, לא פחות ממחוייבותו לאתיקה של שמירת הפרטיות. ואכן קשה לעיתים להסביר לעצמינו, ועל אחת כמה וכמה לצוות חינוכי, את המימד הסיבולי של התרחשויות בחדר הטיפולים, ובעיקר משמעויות של משחק. קשה להסביר למורה כיצד המעבר של הילד מציור בצבעים א-כרומטיים לציור צבעוני רלוונטי לתיפקוד שלו. או - מדוע פריצת דרך ביכולת לשחק (במובן הויניקוטיאני) הינה אירוע מרגש.

ניתן לראות את המפגש בין העמדות כמפגש בין קולות של משתתפים בתוך קבוצה, כפי שהוצע עד כה לעיל, אך ניתן גם לבחון זאת כמפגש בין מגזרים בתוך ארגון. אלבק (1980) מתאר כי בתי ספר הינם אחת המסגרות

העקריות, בהן נפוצות אי הסכמות בנוגע לתחומי העיסוק של אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי. קטן וסאנג (1984) טוענים כי חלוקת העבודה בין אנשי המקצוע השונים הינה תוצאה של יחסי כוח ומשא ומתן על חלוקת אחריות ומטלות ארגוניות. המהלך בו הצוות החינוכי מצידו מאפשר את המרחב הטיפולי, מחד גיסא (כולנו מכירים מצבים רבים בהם ללא תמיכה של המחנכת, הילד יסרב להגיע לפגישות), והמטפל, מאידך גיסא, בוחר את מוקדי העבודה הטיפולית/הייעוצית עם הילד בזיקה לנושאים המתוארים ע"י הצוות , הינו תהליך אשר מעורבים בו גם אינטרסים שונים של השותפים.

יחסי כוח מתקיימים בכל ארגון. על מנת שהשיקולים המקצועיים יהוו את המוקד מרכזי לקבלת החלטות (לעומת הכרעות הנלקחות משיקולים של כוחניות ושמירה על אינטרסים), חשוב שהצוות יכיר באופנים השונים של 'שותפות'. מנור-בנימיני (2008) טוענת כי הציפיות של אנשי מקצוע מעצמם ומאחרים ביחס אליהם תלויות באופן בו הם תופסים את הדרכים בהם הם עובדים ביחד. בעקבות תאורטיקנים קודמים מנסחת מנור-בנימיני אבחנה בין סוגים שונים של עבודה רב-מקצועית, המבטאים כל אחד תפיסה שונה אודות מהות השותפות:

צוות מולטי-דיסציפלינרי - כל איש מקצוע מאבחן, מכין ומיישם תוכנית עבודה נפרדת עם הילד (או לחילופין הכיתה).

צוות אינטר-דיסציפלינרי- כל איש מקצוע מאבחן ומטפל בנפרד, אך כל העובדים עם אותו הילד נפגשים באופן קבוע לדיווח ויידוע הדדים.

צוות טרנס-דיסציפלינרי – כל איש מקצוע מאבחן ומטפל בנפרד, אך תוצאות האיבחון ותוכניות העבודה מתגבשות בדיונים משותפים של כלל אנשי הצוות.

צוות העובד באופן טרנס-דיסצפלינרי מסוגל פוטנציאלית לפתח **חשיבה סינרגטית,** כך שרעיונות חדשים ויצירתיים נולדים מתוך השיח המשותף. נדמה כי המקרה של א. , נער הסובל מ PDD, מדגים מהלך מסוג זה: המטפל ניסה בתחילה להגמיש את נוקשות החרדות של א. בנוגע לעתידו, אך ללא תועלת, ואילו הצוות היה שקוע בנסיונות (אף הם כושלים) לווסת את התגובות התוקפניות של א. כך שלא תפגענה בביצוע שלו. רק במפגש המשותף נוצרה התובנה כי א. חייב לקבל תחושה של הישג ריאלי, ואלמלא כן לא יוכל ל'שחק' עם תפיסת העתיד שלו, ובעקבות זאת התהווה הרעיון להציע לו להתכוונן ל 'תעודת 12 שנות לימוד' .

יחד עם זאת, חשוב שנכיר בכך כי פעמים רבות המפגש הבין-מקצועי אינו הרמוני, ובתוך המשא ומתן בין השותפים גם מתעוררות מחלוקות, אשר לעיתים מעוררות חרדה רבה. דוגמא: לקראת הטיול השנתי הצוות החינוכי נמצא במתח רב, ונוטה למנוע מתלמידים עם בעיות משמעת לצאת לטיול, מתוך חשש להפרות משמעת עד כדי הופעת התנהגויות מסכנות, וכן מתוך חשש להשפעה על תלמידים אחרים. מתוך היכרות אישית של היועצת עם ג. היא סבורה כי החלטה מסוג זה לגביו תתפרש על ידו כוויתור עליו, וכאישור לחוויה רודפנית שלו, ש'מסמנים', כך שנמנעות ממנו הזדמנויות להוכיח את עצמו כמי שמשתנה. הטיול מתקיים בתקופה בה היועצת מתרשמת מגילויים ראשונים ושבריריים של מוטיבציה מצידו של ג. להוכיח את עצמו כמי שמגלה יותר אחריות, והיא מתרשמת כי להחלטה למנוע ממנו לצאת לטיול עלולות להיות השלכות מדכאות לגביו. ניתן כמובן גם להבין את החשש של הצוות. רק שמירה על תודעה מקצועית מובחנת, והכרה כי העמדה החינוכית והטיפולית אינן בהכרח מתעניינות באותו אובייקט (הצוות – בהסדרה של המשמעת, והיועצת – בחוויה של ג.), ואינן בהכרח שותפות להגדרות יעדים מיידיים משותפים – יוכלו הצוות והיועצת להמשיך להדיין, ולמצוא אלטרנטיבה יצירתית, וזאת מבלי שעמדה אחת 'תנצח' או תבלע את השנייה.

כיוונים ישומיים:

עמדות נישאות ע"י אנשים, והמפגש בין עמדות כשהוא מתרחש בתוך ארגון הינו למעשה מפגש אנשים. החיכוך מעורר תהליכים בינאישיים, קבוצתיים וארגוניים המעוררים אי נחת ואף חרדה. לעיתים הצוות החינוכי נותר בתחושה שהטיפול מתקיים במנותק ובבועה ממצוקות היומיום, ואילו מטפלים לעיתים נותרים בתחושה של מיעוט מבודד, המתקשה לשמור על קול ייחודי בתוך מערכת רבת עוצמה. מצידם של דמויות טיפוליות כל ה'התקפות', שתוארו לעיל (לחץ לידיעה, לשמירה על לכידות צוותית ועוד) מיצרים איום של 'הבלעות' של כל אופן חשיבה שאינו פונקציונלי-הסתגלותי, בתוך הלך רוח חינוכי. כדי לשמור ולשמר קול מובחן נדרשת תפיסת זהות מקצועית טיפולית מגובשת ומעובדת, וזו תלויה במערכת מושגית בהירה, אשר תחדד את המשמעויות וההשתמעויות של כל אחת מהעמדות– החינוכית והטיפולית. השימוש במאמר הנוכחי במונח 'עמדות', בהשאלה מה'עמדות' הקלניאניות (-עמדה סכיזו-פרנואידית ועמדה דפרסיבית) מזמין אפשרות של גמישות ותנועה בניהן, והמנעות מזיהוי פרופסיונלי חד משמעי. יחד עם זאת, יש בדברים הזמנה לסימון כיוון, ובעיקר מודעות וערנות לצורך ליצור בכל משבר או מצוקה מערך התערבותי שלם, שבו יש מקום לשתי העמדות – כך שניתן יהיה להתבונן על הילד הן נקודת המבט ההסתגלותית בצד זו שחוקרת את הסובייקט, כאשר צירופן מאפשר מבט רב מימדי על הילד (ראה גם גרינולד-קשאני ומטיחס, 2009).

ברצוני להציע להלן מספר אפשרויות ישומיות העומדות בפני המטפל העובד בתוך מערכות חינוכיות:

הנכחת שפה טיפולית בשיח חינוכי:

המטפל יכול לזהות מבני עבודה קיימים, בהם מתרחשים דיונים אודות ילדים או מצב הכיתה, ולהנכיח את הקול הסובייקטיבי כפעולה מכוונת, המאפשר נקודת מבט החורגת מההיבטים התפקודיים גרידא. למשל, בישיבות פדגוגיות להתעניין בחוויה של הילד – **האם הוא עצמו מוטרד ממצבו התפקודי? באילו תחומים מרגיש קומפיטנטי, ובאילו חווה קושי? האם בעל מוטיבציה לשינוי ובאיזה תחום? מהי תפיסת העתיד שלו? למה שואף? האם מחבר בין התיפקוד הנוכחי להשפעה על אפשרות מימוש רצונותיו בהמשך? וכד'.** בהקשר זה חשוב להבחין בין התעניינות מנקודת מבט טיפולית לעומת עבודה עם תלמידים על מיומנות של 'סנגור עצמי'. באלה האחרונות ישנה הכוונה לכך שהילד ילמד לבטא את עצמו, ולהסביר באופן קומוניקטיבי את עצמו במגעיו עם הסביבה, כך שמבחינה זו, סנגור עצמי מבטא התפתחות של מיומנות בתחום החברתי. לעומת זאת, מנקודת המבט הטיפולית רמת הבהירות של הביטוי העצמי, היכולת לשאת דברים מול אחרים וכו' הינה משנית לאפשרות של הפרט להתחבר לעצמו ולהביע מחשבות ורגשות באופן כלשהו. אין הכוונה להמעיט בחשיבות הבעה קומוניקטיבית, אך מרכז ההתעניינות בעמדה זו אינו תפקודי אלא סקרנות לגבי עולמו הפנימי הסובייקטיבי של הילד. ישיבות רב מקצועיות יכולות אם כן באופן הזה לשמר פוליפוניות (רב-קוליות), כך שחלק מהמשתתפים יציגו את את ההיבט התפקודי וחלקם את קולו הסובייקטיבי של הילד.

פעמים רבות עולה שאלה בנוגע למשמעות של שילוב תוכניות התנהגותיות במערך ההתערבות, ואופן השותפות של דמות טיפולית במהלך זה. אם נחזור למקרה של נ. המוצג בראשית המאמר, הרי שאין ספק כי לתוכניות התנהגותיות יש עוצמה רבה בתהליכי שינוי, ולחלק ניכר מהילדים הן מהוות הזדמנות לפתיחת מעגלים חדשים של אופני התקשרות עם הסביבה, באמצעות הכחדת התנהגויות מרחיקות, מחד גיסא, וחיזוק התנהגויות מקרבות ומעודדות שותפות וחבירה, מאידך גיסא. לדעתי, אין כל מניעה כי מטפל יקח חלק בתוכניות כאלה, עם זאת הייתי מציעה שדווקא בשל עוצמתן הסוחפת, חשוב שהמטפלת לא תזנח את אחריותה לחקירת המשמעות האישית של

ההתרחשויות. כלומר, תגלה עניין באופן בו מפרש הילד את התוכנית: האם תופס אותה כמסייעת או מדכאת? עם אילו חלקים בה הוא מזדהה ועם אלה פחות? באיזו מידה מרגיש שותף לעיצוב התוכנית? כיצד תופס את תהליך ההשתנות – באיזו מידה השינוי נתפס בעיניו כחלק ממנו או כזר לו? ובעיקר – **כיצד ניתן לעצב את הניואנסים של התוכנית ההתנהגותית בהתאמה לילד הספציפי בהקשר המסויים. וכן,** מה תהיה המשימה/המשימות המוגדרות אותן יצטרך לבצע, בהתאמה למוטיבציה ולכוחותיו ברגע נתון.

בנקודה זו ברצוני לשתף, כי דווקא בשל הפיתוי הרב שישנו בהתמקדות בתפקוד, וכן בשל רצוני להבחין עבור הילד בין מקומי כדמות מטפלת למקומם של אנשי הצוות הטיפולי, אני נוטה בחלקים המתרכזים בתפקוד להזמין לעיתים לתוך (חלק מ)הפגישה, את ההורים או המורה, וזאת כמובן בהסכמה מוקדמת של הילד. אלה יכולים לייצג את הקול המוטרד מהתפקוד בתחום זה או אחר, ואילו הדבר מותיר עבורי מרחב מסויים של אי הזדהות עם היבטים אלה. כך שכאשר אני מציעה 'תפירה' של מהלך התנהגותי או 'חוזה' בין המבוגר לילד, אני נותרת במידה מסויימת מחוץ לשיח התפקודי – לא לי הוא חייב דין וחשבון על השינוי, וכך גם יוכל לראות בי לא רק אובייקט רודפני עבורו בהמשך (למשל, ירגיש צורך להתנצל בפני, או ימנע מלפגוש אותי), במידה ולא עמד בהסכם שנקבע.

שיח טיפולי – התמקמות כאחר:

מנוני טוענת כי "גורלה של האנליזה נחרץ בחמש הפגישות הראשונות, ויש לנקוט מן ההתחלה בכל אמצעי הזהירות כדי להבדילה מן הצורות האחרות של החינוך המתקן" (עמ' 154). נסיונה המקצועי העשיר יכול לסייע כסימון כיוון, ונקבל, אם כן, כהנחת יסוד שהפגישות הראשונות של המטפל עם הילד הינן קריטיות בעיצוב המסגרת של 'מה שאנו עושים כאן'. עפ"י נסיוני, רוב הילדים גם אם אינם מודעים לכך, רואים את המטפל, העובד במסגרת חינוכית, בו זמנית כשייך ולא שייך לצוות החינוכי עוד לפני פגישתם הראשונה עימו. הוא שייך לצוות בהיותו חלק מהמבוגרים, שבוודאי רוצים ממנו משהו, ומניח כי המטפל בדומה לאחרים רואה פגיעה תפקודית באופן שיפוטי-שלילי, ואינו שייך במובן זה שבעל תפקיד ייחודי לעומת שאר המורים. מצד אחד, הילד מגיע עם תפיסה מוקדמת של עצמו כמאכזב או פגום בעיני דמות סמכות (הרי הופנה כי סובל מבעיות התנהגותיות, חברתיות ואחרות), אך מצד שני, גם מקווה כי יתפתח משהו אחר, ובמובן זה רב הילדים מגיעים עם מידה של טרנספרס חיובי. ילדים שונים נמצאים במקומות שונים על הרצף בין צפייה ל'עוד מאותו דבר' לבין ציפייה לשונה ותקווה לאחר. נראה כי חשוב שהמטפל יגיב כבר בפגישות הראשונות לציפיות הטרנספרנסיאליות הללו וימקם את עצמו מולן.

דוגמא: ב. נערה עם אינטלגנציה תקינה, כמעט ואיננה מתפקדת מבחינה לימודית. בישיבה הפדגוגית הוחלט כי אם לא יתרחש שינוי משמעותי בתפקודה הלימודי לא תוכל להמשיך את לימודיה בבית הספר. ב. הביעה נכונות להגיע לפגישות עם יועצת בית הספר. בפגישה המשיכה את הדיבור בדומה לסגנון שהיא מקיימת מול הצוות החינוכי – 'אז מה תעשו לי? תעיפו אותי? אז תעיפו אותי!'. היועצת יכולה להתייחס לעצם אי המובחנות שביצירת הקשר. למשל לומר – ' אני תוהה אם בכך שאת מגיעה לכאן, את מביעה איזו משאלה פיצפונת, שלפחות אחת מאיתנו תשמור על התקווה, שכאן נוכל לדבר אחרת. לא רק דיבור של - כן יעיפו – לא יעיפו'. בצעד המשכי, תוכל היועצת לסמן כי היא רואה בדברים של ב. גם מימד סיבולי – 'נראה לי שאת אומרת שאת כבר התארגנת בצורה כזו שכבר אף אחד לא יוכל להפתיע אותך ולהרע לך. הצבת את עצמך במקום חסין – בך כבר אי אפשר לפגוע'. במהלך של שתי התערבויות אלה היועצת משרטטת עפ"י הבנתי שני סימונים עקרוניים – האחד, המובחנות שלה לעומת הצוות, זאת בצד הערנות שלה למה שמתרחש במציאות הבית ספרית, והשני, סוג השיח המתנהל. במובן זה ההתערבות השנייה הינה התערבות פרשנית ולא חינוכית, בהיותה חותרת לחשוף את המימד הסובייקטיבי שמאחורי ההתנהגות התיפקודית. אם נדייק זאת בעקבות פונגי וטרג'ט (1996), משמעותה של התערבות זו היא לאו דווקא במידת הדיוק

או ה'אמיתיות' של הפירוש, אלא בסימון האפשרות, שניתן להתבונן על ההתנהגות של ב. לאו דווקא באופן הרגיל (האם עומדת בנורמה או לא) אלא כמבטאת כוונות אופציונליות שונות. התערבות זו הינה נסיון לחלץ את נ. מתפיסה שבה המציאות החיצונית והפנימית חד הן (כלומר, אם מתנהגת באופן חריג זה לא אומר שמתכוונת להיות שונה, אלא למשל, שרוצה לסמן את עצמה כבלתי ניתנת לפגיעה). כמובן, שאם התערבות זו מתרחשת במקביל להתערבות של היועצת מול הצוות החינוכי, כך שגם המחנכת תוכל להרחיב את יכולת ה'משחק' שלה, ולראות את ב. לא רק כמתריסה ('ברור שהיא לא שמה עלינו'), אלא כמתגוננת, האפקטיביות של מהלך ההתערבות תהיה לעין שיעור גבוהה יותר. כלומר, מרחב המשחק הינו מרחב אינטרסבייקטיבי, המתהווה מתוך האינטראקציה של המשתתפים השונים זה עם זה.

חשוב לציין כי במקרה של ב. התחושה היתה כי ההתערבות הגיעה מאוחר מידי. התחושות השליליות ההדדיות היו כבר כה עוצמתיות, שהיועצת לא יכלה לשאת לבדה את המאמץ ליצור מרחב משחקי, שכן בשלב שבו המקרה הופנה לטיפולה, כבר לא היה פרטנר בשום צד (לא ב. ולא המחנכת) ששיתף איתה פעולה בכך. סוגיית ה timing הינה אם כן סוגיה חשובה מאוד, התערבות יכולה להניב פרי, כאשר היא מתרחשת לפני שהצוות והילד גיבשו עמדה פנימית סגורה. במקרים בהם הרגשות ההדדיים עוצמתיים ושליליים, על מנת שהתערבות תהיה אפקטיבית המטפל חייב בעל ברית נוסף, השותף לתקווה. שותף כזה יכול להיות דמות נוספת במערכת שעד כה לא היתה מעורבת (למשל, המנהלת, שבין אם מתוך אפטיה לתלמיד או מתוך רצון להקטין את סטטיסטיקת הנשירה...) רוצה שיתקיים משהו אחר.

פרטיות וסודיות – מעברים על הגבול:

סוגיה נוספת עימה מתמודדים מטפלים, העובדים בתוך מסגרת חינוכית, נוגעת למעברים של אינפורמציה והתרשמויות מתוך חדר הטיפולים החוצה, ומחוצה לו לתוכו. האתיקה המקצועית מחייבת שמירה על סודיות של המטופל. יחד עם זאת, המנעות מוחלטת משיתוף בין המטפל לצוות החינוכי יוצרת כשלעצמה הוויה שגילוייה פעמים רבות הרסניים. מפרספקטיבה פסיכודינמית ניתן להבין את ההרסנות הפוטנציאלית כתוצאה של שימוש במנגנוני פיצול והשלכה. לעיתים הפיצול מתרחש ברמה תוך-אישית של הילד – מפריד חלקים שונים של העצמיות שלו ומשליך כל חלק על דמות אחרת בסביבתו. למשל, מבטא חלקים תוקפנים בכיתה לעומת חלקים של חיפוש קירבה ורוך, הבאים לידי ביטוי בפגישות הטיפוליות. דרמת הפיצול עשויה להתרחש ברמה הבינאישית, ביחסים בין אנשי הצוות: כאמור, בקרב הצוות החינוכי עשויות לעלות מחשבות פרנואידיות בנוגע למה שמתרחש בחדר הטיפולים, או לחילופין, תחושות של חוסר אונים וכעס, בשל מה שקשייו של הילד מעוררים. רגשות אלה עשויים להיות מושלכים ע"י הצוות על המטפל, ואז נראה תגובות של כעס רב כלפי המטפל כאילו הוא עצמו המקור לקשיים. הסיכוי לשימוש במנגנונים של פיצול והשלכה גדל כאשר המטפלת מצידה מבדילה את עצמה, ומסמנת את הטיפול כ'אקס-טריטוריה' באופן מודגש. גם מצידו של המטפל קיימת סכנה של שימוש בפיצול והשלכה, כאשר הוא נשאב (לעיתים בשל תחושות המצוקה והניכור שלו עצמו מהמערכת והצוות) להזדהות עם תפיסותיו של הילד. בהעדר דיאלוג מתמיד של השפעה ומושפעות של המטפלת כלפי הצוות ולהיפך, ישנה סכנה ממשית של הקצנת תהליכי פיצול והשלכה.

במונחים ארגוניים, נוכל להתייחס לייעוץ/טיפול במערכת כפרקטיקה הממוקמת על הגבול. בהיותו פועל בעיקרו באזור של שינוי, משבר או השמה (- העברה ממערכת אחת לשניה) הוא עוסק ללא הרף בשאלות של גבולות (טליאס, 2009). המנעות מוחלטת ממעבר של אינפורמציה או רשמים מתוך טיפול, המתרחש בין כותלי בית הספר, אל הצוות החינוכי, יוצרת הוויה של תת מערכת שהינה בעלת גבולות לא חדירים בתוך ארגון, אשר הגבולות בו לרב הרבה יותר נזילים. התמקמות כזו של מיצוב 'גבול עבה' בלשונו של גורביץ (2007), מייצרת רוח של תפיסה מכניסטית,

ואיפיונים של סגירות וקיום עצמי. בנוסף, פיתוח מנגנון מושקע של שליטה ומסגרות חוזיות, מחבלת באפשרות החשובה של יצירת פוריות כתוצאה מדיאלוג, שיכול להתקיים רק במצב של 'גבול דק'. כמובן, מדובר על דרך שיש לנווט בה בזהירות, תוך ערנות לצורך לשמור על פרטיות של הילד, והחובה האתית בשמירה על סודיות, מחד גיסא, לבין הצורך להמנע מההשלכות השליליות המתעוררות מכינון 'גבול עבה', מאידך גיסא. בעניין חשוב זה לא נוכל להרחיב בהקשר הנוכחי.

סיכום:

המרחק הפיזי של חדרי הטיפול בקליניקות (ציבוריות או פרטיות) ממציאות החיים הבית ספרית של הילד, עשוי גם לבטא מרחק מנטלי של המטפל וההתרחשות הטיפולית ממציאות זו. המרחק מאפשר שקט ומרחב של הקשבה לחוויה של הילד, באופן בו הוא בוחר להביא את עצמו בפני המטפל. לעומתם, תהליכים טיפוליים המתרחשים במסגרת חינוכית סובלים, מצד אחד, מ'רעשים' שונים - לחצים לשינוי התנהגותי (ורצוי מהיר...), והידרשות המטפל להתמודד עם תהליכים בין-אישיים וארגוניים הנלווים להיותו חלק מצוות רב מקצועי. מצד שני, חשיפה זו איננה מאפשרת למטפל ל'התענג' על הבועה הטיפולית, ומחייבת אותו באמצעות תגובות הסביבה, להתייחס באופן מתמיד לשינויים או לחילופין להעדרן של תמורות, במצבו המנטלי של הילד. הרצוג (מצוטט אצל Hurry, 1998) טוען כי טיפול אינו יכול להיות מושלם עד אשר המטופל יוצר קשרים בעלי דפוסים חדשים עם אחרים בסביבתו. בהמשך לכך, נוכל לטעון כי הקירבה של המטפל העובד במסגרת חינוכית לסביבה המציאותית של הילד מאפשרת לו בחינה טובה יותר של הדפוסים המדוייקים והמתחדשים, אותם מייצר הילד בעקבות הטיפול ושינויים חינוכיים. טיפולים באוריינטנציה פסיכודינמית סופגים בשנים האחרונות ביקורות רבות משום שאינם מבוססי ראיות דיים (ברמן, 2011). ניתן, אם כן, לראות את הקירבה בין הטיפול למסגרת החינוכית כהזדמנות לתיקוף העבודה הטיפולית או במידת הצורך – לשינוייה. דיאלוג מתמיד בין העמדות מאפשר למקם את הטיפול כמכוון לרוח **'נתמכת ראיות'.**

בנוסף לכך, הקירבה של המטפלת למרחבי החיים בהם מתקיימים דפוסי אינטראקציה מגוונים של הילד עם סביבתו, מאפשרת לה לשאת בתוכה באופן מנטלי ילד 'שלם' יותר, על חלקיו המורכבים. בכך נמנעת השאבות לאותם חלקים שהילד בוחר להביא בדיווחיו/במשחקו לסיטואציה הטיפולית, או לאלה העולים בקשר הטרנספרנסיאלי הייחודי בין הילד לבינה, תוך התעלמות מחלקים אחרים הבאים לידי ביטוי בסיטואציות חיים שהינן יותר תובעניות ושיפוטיות.

וירצברגר (2010) מתאר את המפגש בין נקודת המבט החינוכית לטיפולית כמפגש בין שפות שונות. הוא קורא לפסיכולוגים החינוכיים ללמוד את המערכות מתוך השפה שלהן, כמו גם להביא את המבט החוקר והתר אחר סיבות ומניעים לתוך השפה החינוכית הממוקדת לרוב בהתנהגות, בראוי ובסנקציה. חשוב להכיר בכך,**שמפגש זה בין עמדות כאשר הוא מתקיים בתוך מערכות, אינו נושא רק אופי תודעתי אלא מעורר דינמיקות האופייניות למתרחש במפגש בין תת-קבוצות או בין מגזרים פנים ארגוניים שונים.** חיכוך זה יוצר איום מנטלי הדדי (למשל, חרדת הבלעות) כמו כן ארגוני (חרדות סביב סוגיות של יחסי כוח ושאלות של פרסטיז'ה בין אנשי צוות/מקצוע שונים). יחד עם זאת, במגע בין-מקצועי תמידי זה טמונה גם הזדמנות למחשבות חדשות, ולריענון של תוכניות התערבות. מסגרות טיפוליות אלה, אשר כיום הינן חלק מכל מערך שירותים שבתי הספר מציעים, מחייבות מחשבה מחודשת על האתיקה הטיפולית (למי/למה נתונה הנאמנות המקצועית של המטפל) ועל הפרקטיקה הטיפולית (עיצוב ה setting הטיפולי בתוך מסגרת חינוכית והתאמת מוקדי ואופני ההתערבות). בנוסף לכך, יש להמשיך לתת את הדעת על המשמעויות השונות הכרוכות במקומה של דמות טיפולית בתוך מסגרת שאיננה במהותה מכוונת ליעדים אלה. ניתן אף להעיז ולטעון, כי נוכחותה של חשיבה טיפולית עשויה להפרות את כיווני החשיבה לא רק בתחומים הקרובים לעיסוקה של הפרופסיה (הבנת עולמו הפנימי של הילד או היחסים בצוות), אלא אף לתרום לתחום הנתון

בליבה של העשייה החינוכית – התחום הפדגוגי. תרומה אפשרית הינה סביב סוגייה שאנו ערים יותר ויותר לחשיבותה – **האינטראקציה בין מורים לתלמידים** בהקשר של השפעתה על תהליכי למידה (פישר ומיכאלי, 2010).

לאור המוצג במאמר הנוכחי ניתן להציע מספר **כיווני חשיבה וחקירה המשכיים:**

מנקודת מבט קלינית, חשוב להוסיף ולחקור באילו אופנים החשיפה של המטפל להיבטים החינוכיים-הסתגלותיים של הילד משפיעה על ההקשבה שלו לאורך המפגש הטיפולי/ייעוצי ועל בחירת ההתערבויות. גישות פסיכולוגיות שונות (ולא דווקא פסיכודינמיות) , אשר שמו להם כמטרה לחקור את הסובייקט, מסמנות לרב גבולות ברורים בין החוץ לפנים, בין הטיפול לבין מה שמתרחש מחוצה לו בממשות, ולרב מסתפקות בסיפור ובפרשנות של המטופל בנוגע למתרחש במציאות חייו. חשוב אם כן לבחון, כיצד חלחול תמידי של מידע מהחוץ משפיע על עיצוב המהלכים הטיפוליים ודפוסי הקשר הטרנספרנסיאלים והקאונטרטרנספרנסיאלים. בהקשר זה נשאל למשל, מה הילד חושב או מרגיש ביחס לכך שהמטפל יודע עליו פרטים מסויימים, שלא הוא בחר לשתף. ומן הצד השני, נתעניין למשל, באיזו מידה מתעוררים במטפל רגשות כגון כעס, אכזבה או לחילופין הזדהות, שאינם תוצאה ישירה של ההתרחשות בקשר הטיפולי, אך קשורים לאירועים מחוץ לחדר הטיפולים, שלעיתים המטפל עצמו הינו עד ישיר או עקיף להתרחשותם. באיזו מידה חלחול מהסביבה משפיע על ההקשבה של המטפל – מרחיב או מצמצם אותה, מגביר את היכולת של המטפל למנטליזציה ולמשחק או מכניס אותו לסד של צורך "להנפיק תוצאות'. במילים אחרות, נוכל לשאול כיצד פרופסיה המתקיימת בהווייה רב מקצועית טרנס-דיסציפלינרית (עפ"י הגדרה המובאת אצל מנור-בנימיני, 2008), מייצרת חשיבה טיפולית מתחדשת?

מנקודת מבט מערכתית חשוב לבחון ולהעריך מערכות חינוכיות בהקשר למידה בה הן מצליחות למצוא באופן כולל איזון בין העמדות השונות, ולתת ביטוי משלים להיבטים השונים, המחזיקים צרכים התפתחותיים מגוונים של הילד/ים. ישנן מערכות אשר בהן ישנה 'התלהבות יתר' מהעמדה הטיפולית, וכל אנשי הצוות מגלים הבנה אמפטית לקשיים של הילדים, חוקרים בתשוקה רבה את תולדותיו, או לחילופין הופכים כולם ל'משקפים' או 'מפרשים' לילד את רגשותיו. מערכות אלה סובלות מחוסר איזון לא פחות מאלה אשר בהן הראייה של הפרט או הקבוצה מצטמצמת לשפה של תוצרים, תפוקות, ציונים וכד'. מערכות מאוזנות מספקות מגוון רחב של אובייקטים – אובייקט התפתחותי, בצד אובייקט טרנספרסניאלי. בנוסף, ניתן לבחון את מידת הגמישות של מערכת באפשרות של אנשי מקצוע שונים לנוע במידה זהירה של אלסטיות בין התפקידים השונים, ולדבר בעיתות שונים שפות שונות.

מנקודת מבט חברתית, ניתן לחקור את האופנים השונים בהם השפה הטיפולית מחלחלת לתוך השפה החינוכית, ו/או משפיעה על עיצוב דפוסי ההתייחסות בין המורים לתלמידים, ובין אנשי הצוות השונים. כך למשל, נוכל לבחון באיזו מידה הילד נבחן ונמדד על פי קריטריונים חיצוניים (שהינם לעיתים מנוכרים לו), או על פי מטרות שהוא סימן לעצמו, מתוך שיח משותף. דוגמא נוספת: הכרה של מנהל שמתחים וקונפליקטים עזים בין חברי הצוות או בינו לבין (חלק) מהצוות, הם תוצאה של המצאות בתנאי אי וודאות וחרדה (למשל, סביב שינויים בתנאי העסקה בשל 'אופק חדש' או 'עוז ותמורה'), עשויה להגביר את היכולת שלו למנטליזציה, להפחית את חרדותיו מפני כאוס ארגוני, ולאפשר לרעיונות חדשים לעלות. תובנה מסוג זה הינה ביטוי נוסף ברמה המערכתית לחלחול השפה הטיפולית לתוך מסגרת חינוכית.

מנקודת מבט ארגונית חשוב לבחון, מהם מבני העבודה ומבני השיח בהם יכולים אנשי הטיפול לפגוש את הצוות החינוכי, להשפיע הדדית, וליצור מפגש פורה בין העמדות. סוגייה זו של זיהוי מוקדי שיח/עבודה משמעותיים (למשל, החלטה של איש טיפול להשתתף בישיבות פדגוגיות, מתוך רצון להשפיע על מוקדי הדיון והחקירה) או לחילופין יוזמה של כאלה (למשל, מיסוד ישיבות רב מקצעיות סדירות) הינה קריטית, על מנת לאפשר מיכל סביר למגע בין השפות

ולחיכוך בין אנשי צוות שונים, כך שאלה לא יהפכו למקור לתחושות רודפניות הדדיות אלא להרחבה של היכולת ל'שחק עם המציאות' (ראה גם גרינולד-קשאני ומטיחס, 2009). בנוסף, בהנתן מרחבי שיח משותפים, ניתן לחקור את הדינמיקות ויחסי הכוחות המתקיימים בהם, המשפיעים על עיצוב השיח לא פחות מאשר המפגש בין נקודות המבט העקרוניות השונות.

ביבליוגרפיה

אוסטרויל, ז., (1995), *פתרונות פתוחים: טיפול פסיכולוגי בילד ובסביבתו*, ת"א: הוצאת שוקן.

אופנהיימר, ד. ובנימיני, ד., (2001), על מושג הגבול, *אנליזה ארגונית, 4, עמ' 45-39.*

אלבק, ש., (1980), תפקידו של העובד הסוציאלי בבית הספר, תפיסת התפקיד בעיני בעלי המקצועות השונים בבית הספר, *חברה ורווחה*, ג, 4, עמ' 443-428

בר-לב אליאלי, ר., מחשבות על החיבור בין פסיכואנליזה וחברה: השימוש בהבנה פסיכואנליטית בעבודה עם קבוצות וארגונים, בתוך: הטב, י., (עורך), *פסיכואנליזה הלכה ומעשה*, תל אביב: הוצאת דיונון, עמ' 455-441.

ברמן, א., (2011), טיפול פסיכודינמי: טיפול נתמך ראיות. (גירסא אלקטרונית). נדלה ביום שלישי 16 באוגוסט 2011, מאתר פסיכולוגיה עברית.

גורביץ', ז'., (2007), *על המקום*,תל אביב: הוצאת עם עובד.

גרינולד-קשאני, נ. ומטיחס, ו., (2009), אתגרים ארגוניים בעבודת הפסיכולוג החינוכי: מבט מחודש על הנחות היסוד של הפרקטיקה המקצועית, *פסיכואקטואליה*, עמ' 31-16.

וינשטיין, ש. ורונן, י., (2001), "למחוק את הזכרון, את ההבנה ואת התשוקה": תרומת אי הידיעה לעבודת צוות טיפולי רב-מקצועי. *חברה ורווחה, כרך כ"א, עמ' 210-195*

וירצברגר, א., (2010), הרצאת פתיחה: כנס פסיכולוגים חינוכיים מחוז דרום.

טליאס, מ., (2009), 'חסרי גבולות': על גבולות וארגונים, *אנליזה ארגונית, 14, עמ' 32-25.*

מיטשל, א., ובלאק מ. ג'., (2006), *פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית*, תולעת ספרים.

מנוני, מ., (1993), *הילד מחלתו והאחרים*, תל אביב: הוצאת עם עובד.

מנור-בנימיני, א., (2009), *עבודת צוותים רב-מקצועיים: תאוריה, מחקר ויישום*, משרד החינוך, המינהל הפדגוגי: האגף לחינוך מיוחד.

קטן, י., וסאנג ק.ט., (1984) יחסים בין עובדים מקצועיים בארגוני רווחה רב מקצועיים – סוגיות עיוניות ומעשיות, *חברה ורווחה*, עמ' 336-317.

Bion, W.R. (1961), *Experiences in Groups and Other Papers*, New York: Basic Books.

Fonagy, P. & Target, M. (1996), Playing with reality: I. Theory of mind and the normal development of psychic reality, *International Journal of Psychoanalysis, 77,* PP. 217-233

Freud, A. (1965), Normality and Pathology in Childhood: Assessment of Development, New York: International Universities Press.

Freud, A. (1976), Changes in Psychoanalytic practice and experience, In: *Writing of Anna Freud*, Vol. 8, New York: International Universities Press, 1981, PP. 167-185.

Hurry, A. (1998), Psychoanalysis and developmental therapy, In: Hurry, a. (Ed.), Psychoanalysis and Developmental Therapy, London: Karnac Books,

Gibbard G.S., Hartman J.J. & Mann R.D. (eds) (1974), *Analysis of Groups*, San Francisco: Jossey-Bass.